

人工呼吸を受けるという経験の存在論 — 機械論から全体論へ、生きられた身体と世界とのつながりを問う (From the Inside・ICM2026)

出典 Bein T, Brodie D, Quintel M. The ontology of being ventilated—a less mechanistic and more holistic understanding. Intensive Care Med. 2026;52:602-604. doi:10.1007/s00134-025-08274-5

掲載誌 Intensive Care Medicine (2026-01-12)

原著 doi.org/10.1007/s00134-025-08274-5 (本文PDFは別途)

原題 The ontology of being ventilated—a less mechanistic and more holistic understanding



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み **変わらないこと**:換気設定・鎮静プロトコル・離脱基準など、生理学に基づく管理そのものは1つも変わらない。この論文にはそれを変える根拠が無い。

変わりうること(=ケアの語彙と記録の設計)

- **「空気飢餓(air hunger)」を測って残す**:著者らが具体的に挙げた4つの介入のうち、当院で最も実装しやすいのがこれ。痛み(NRS・CPOT)とせん妄(CAM-ICU)は毎日記録しているのに、呼吸困難＝患者にとって最も存在を脅かす体験は記録項目に無い。「息が苦しいか」を1日1回、痛み・せん妄と同じ列で聞いて残す運用を検討する
- **非同調を「波形の異常」だけでなく「患者の闘い」として扱う**:著者らは非同調の体験を「呼吸するための闘い」「機械との闘い」と表現し、実存的恐怖に結びつくとした。波形で非同調を見つけたときのカルテ記載に、設定変更だけでなく患者の表情・訴えの1行を加える(→ [人工呼吸器の非同調\(Asynchrony\)](#))
- **抜管直後の「あなたは誰で、いま身体はどうで、ここはどこか」の再方向づけ**:著者らが挙げた「早期の数日間の simple reorientation」。当院ではすでに ICU日記・[Get to Know Me Board](#) — 患者の人格を可視化するホワイトボード(質的研究・JPatientExp2023) 的な取り組みの下地があり、抜管後ラウンドの定型句として組み込める
- **家族と、可能なら患者本人への「丁寧な説明」を人工呼吸開始の意思決定に含める**:著者らは「MVの適応判断そのものに、ここで論じた帰結(自己の変容)を織り込め」と書いている。これは Hotel ICU の連続ケアと ICU意思決定支援の両方に直結する(→ [★Hotel ICU Home](#)、[患者ケアの連続体\(ICU前・中・後\)](#))

Hotel ICU への位置づけ:当院が進めてきた音・光・睡眠・退室後訪問は「環境と体験の改善」だった。本稿はその1段深く、「人工呼吸中の患者は世界とのつながり方そのものが変わっているかもしれない」という前提を置く。介入リストが増えるわけではなく、**既存施策の目的語が「快適さ」から「自己と世界のつながりの維持」に変わる**という読み方が実務的



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: 人工呼吸中・後の患者が強い苦痛を訴えることは、質的研究とPICS研究で繰り返し示されてきた。口渴・呼吸困難・不動・コミュニケーション不能・妄想的記憶・PTSD症状。人間らしいケア(ヒューマナイゼーション)の枠組みも、eCASH・ABCDEFバンドル・HU-CI として既に整理されている
- **Unknown**: それらの体験が「一時的な不快」なのか、それとも**その人の在り方(自己と世界の関係)そのものの変容**なのかは問われてこなかった。従来のアウトカム指標(心理検査・QOL調査)がその変容を捉えられているかも検証されていない
- **What's new**: フッサールの現象学とメルロ＝ポンティの「生きられた身体」を土台に、人工呼吸を**存在論(ontology、=存在の在り方を問う哲学)の問題**として定式化した点。「人工呼吸で救命された人は、自己が変容してしまうのか」という問いを明示的に立て、臨床実践への4つの具体的示唆に落とした。ただし著者ら自身が「答えより問いを多く残す」と認める、検証前の枠組み提示である



全体要約

要旨

ひとことで 人工呼吸は呼吸器系と脳への介入であるだけでなく、「**生きられた身体が世界と存在へ開かれていること**」への介入でもある — 著者らはそう仮説を立て、呼吸を現象学的・存在論的に読み直し、臨床では空気飢餓の記録・抜管後の再方向づけ・丁寧なコミュニケーション・適応判断への織り込みという4点を提案する。

- 呼吸は生物学的機能であるだけでなく「存在の次元」であり、自己意識の形成にも特権的な役割を担う、というのが議論の出発点
- 呼吸を魂・精神と結びつける言語的伝統は洋の東西に遍在する(サンスクリットの atman、ギリシャ語の pneuma、ヘブライ語の ruach、ラテン語の spiritus)。ドイツ語の呼吸 Atmen は atman と同根
- 疾患による呼吸困難は「生への恐怖・無力感・恥・劣等感」を伴い、世界との自律的な交換を損なう。人工呼吸はその交換を機械が肩代わりし、その人を世界の一部であることから切り離す

- 人工呼吸器という「魂を持たない機械」に生の制御が移譲されることの影響は、**検査値・生理学的指標・従来の心理検査やQOL調査では十分に表現できない**というのが著者らの中心的な主張
- 非同調の体験（「呼吸するための闘い」「機械との闘い」）は実存的恐怖に結びつきうる
- 質的研究（Haugdahl 2017）では、人工呼吸中・後の呼吸体験は4項目に整理された：実存的脅威／つらい時間／輪郭を失い際限のない身体／切り抜けること。ある患者は「私はそこに横たわる、どちらかというとアメーバのようなものだった」と語った
- 鎮痛鎮静やせん妄の影響があってもなお、人工呼吸後の患者が語る主題は5つ：人間としての尊厳の維持／状況の受け入れ／困難に耐えること／不十分な相互作用／非現実感
- 著者らは「これらの介入が『存在論的に変容した別人になること』を減らせるかは今後の課題」と明確に留保し、本稿を「何があるか分からないまま存在論の扉をノックする試み」と位置づける

詳細

1. まず前提 — この議論の背景

要旨

5分で背景を掴む **人工呼吸中の患者が実際に経験していること**から始める。挿管され鎮静された患者は、外からは「安定して眠っている」ように見える。しかし覚醒後の聞き取りや質的研究が繰り返し示してきたのは次のような世界である。

- **話せない**: 声を出す経路が塞がれ、痛み・恐怖・要求を伝える手段が奪われる。筆談やジェスチャーは伝わらないことが多く、伝わらない経験自体が苦痛になる(本稿の言葉では「不十分な相互作用」)
- **息が苦しい**: 呼吸仕事量や換気設定が生理学的に妥当でも、患者は「空気が足りない」と感じる。これを **air hunger(空気飢餓)** と呼ぶ。痛みと違い、ICUで定型的に評価・記録されることは少ない
- **機械と息が合わない**: 患者の吸いたいタイミングと人工呼吸器の送気が噛み合わない状態が**非同調(asynchrony)**。波形上の現象だが、患者側の体験としては「息をしようと闘っている」感覚になる
- **時間と身体の輪郭が失われる**: 昼夜・場所・自分の身体の境界が曖昧になり、記憶が断片化する。実際には起きていないことを鮮明に覚えている(妄想的記憶)ことも珍しくない
- **不動と拘束**: 自分で動けず、抑制されることもあり、身体が自分のものである感覚が薄れる

用語の定義(本稿で頻出する哲学用語。初出でここに集約する)

用語	読み・原語	この論文での意味
存在論	ontology	「存在するとはどういうことか」を問う哲学の一分野。本稿では「人工呼吸を受けている人の“在り方”そのもの」を問う枠組みとして使う
現象学	phenomenology	経験(意識)の構造をありのままに記述する学問。フッサールの定義で「体験ないし意識の構造の研究」
生きられた身体	lived body	物体としての身体(解剖・生理の対象)ではなく、私が世界を感じ・関わるときの主体としての身体。メルロ＝ポンティの中心概念
生きられた経験	lived experience	理論化される前の、日常のなかで実際に生きられている経験そのもの
身体性	embodiment	自己が身体を持ち、身体として世界に在ること。自己と身体が切り離せないという捉え方
世界内存在	being-in-the-world	人間は世界から独立した内面ではなく、つねに世界との関わりの中で存在しているという見方
個体化	individuation	自己が一個の存在として形づくられていく過程

従来のICU研究は、これらの体験を **PTSD症状・不安・抑うつ・QOL** といった尺度に翻訳して測ってきた。本稿の問いは「その翻訳で本当に取りこぼしがいないのか」という一点にある。

2. 背景と目的 — なぜ機械論では足りないと言うのか

著者らはまず、人工呼吸(MV)が呼吸不全治療の礎石であり、呼吸生理学の関心が生理学的・診断的・治療的側面に向くのは**必然である**と認めている。そのうえで本稿の視点はより全体論的であり、「機械換気とともに呼吸すること」を存在論的な観点に合わせるものだと宣言する。

存在論は存在の本性を研究する学問であり、それによって「私たちが世界に在ることのあらゆる側面」を映し出す。著者らはここで中心的な問いを立てる。

＞人工呼吸を受けているとき、人間の存在論的な統合性(ontological integrity)は影響を受けるのか。自然の肺のガス交換を機械が置き換えた状態で重症疾患を生き延びることは、**自己の変容(a transformation of self)**をもたらすのか。

そして、思慮深い存在論的アプローチは**患者に対する倫理的により敬意ある態度**につながりうる、と目的を述べる。ここが本稿の実践的な狙いであり、「哲学のための哲学」ではないことを最初に示している。

続けて、呼吸の現象学的存在論が哲学の学術的関心の対象になった経緯を述べる。ドイツの哲学者エトムント・フッサールの構想に基づき、呼吸という現象は自然科学的な実体であるだけでなく、**存在論的・経験的・霊的・身体的・精神的・詩的・元素的・倫理的・意志的・神秘的**という諸次元をもつ哲学的問いでもある、とされた。

著者らのアプローチと仮説は次のように定式化される。

項目	本稿での記述
問い	人工呼吸という状況下で「呼吸経験の生きられた身体」から切り離された人間は、別の存在状態(another condition of Being)にあるのか
もし然りなら	それは全体論的観点から何を意味するのか
仮説	MVは呼吸器系や脳だけでなく、「生きられた身体が世界と存在へ開かれていること(the lived body's experiential openness to the world and Being、メルロ＝ポンティ)」に多大な影響を与える
動機	この省察は、呼吸器領域で働く臨床医が患者を「世界内存在としての人間」としてケアするうえで重要でありうる

「呼吸経験の生きられた身体 (the lived body of breath experience)」という表現は Berndtson (2018)からの引用、「生きられた身体の世界と存在への経験的開かれ」はメルロ＝ポンティに帰される表現である。

3. 呼吸の存在論的現象学 ― フッサールから

フッサールは現象学という学問を「体験ないし意識の構造の研究」と定義し、**経験が世界の事物へ向かう直接性 (directness)**を強調した。主著『イデーンI』では、意識を「何かについての／何かへ向けられた主観的意識」として統合しようとした。すなわち意識はつねに何ものかについての意識であり、特定の概念・観念・思考を介してのみ客観的な事物へ向かう。

現象学が関心を寄せるのは、「**日常の生きられた経験**」の本質的特徴を正確に記述するという根本問題である。呼吸はその手触りのある次元において現象学的に重要な実体であり、著者らは「息をされること (to be breathed)」への全体論的アプローチの試みに呼吸を含めるべきだと述べる。

> ここでの "to be breathed" (能動の "to breathe" ではなく受動形) という語の選び方が、本稿の議論を凝縮している。人工呼吸下の患者は「呼吸する主体」ではなく「呼吸させられる対象」の側に置かれる。

4. 呼吸を魂と結びつける言語的伝統

著者らは、呼吸が「身体と世界の界面における空気の儚い物質化 (ephemeral materialization of air at the interphase between body and world, Oxley & Russell 2020)」であり、東洋哲学・初期の宗教・伝統のなかに常に存在してきたと述べ、4つの語を並べる。

語	言語・文脈	意味
atman(アートマン)	インド哲学	魂、自己。ドイツ語の呼吸 Atmen と同根であることを著者らは指摘する
πνεῦμα (pneuma、プネウマ)	古代ギリシャ語	空気、息、本質
רוח (ruach、ルーアハ)	ヘブライ語	魂、霊
spiritus(スピリトゥス)	ラテン語	精神、魂

これらの語は、呼吸が人間の生 (より一般には人間の存在) の**特別で靈的に負荷のかかった側面**として理解されてきたことを示す、というのが著者らの読みである。

さらに著者らは、さまざまな呼吸パターンが**無意識の葛藤の顕在化**(例: 出生外傷、母体からの分離)や、その他の構造的不安の表れとして解釈されうる、と付け加える。この一節は精神分析的な文献の伝統を短く参照したもので、本稿ではこれ以上展開されない。

5. 呼吸困難から人工呼吸へ ― 世界との交換が断たれるということ

前節を受けて著者らが立てる問いは、**呼吸困難(dyspnea)の含意**、そして極端な場合には**自力で呼吸できず「自分の外側」との交換を維持できないこと**の含意である。

- 疾患に基づく呼吸困難は「生への恐怖、無力感、恥、劣等感」によって特徴づけられ、**世界との自律的な交換を損なう**
- 患者を生かしている機械換気は、自然な呼吸を人工的なデバイスで置き換え、それによって**その人を世界の一部であることから切り離す(disconnects the person from being part of the world)**

ここで著者らは重要な留保を置く。慢性の呼吸困難や倦怠を抱える患者にとって、MVは生命を確保する助けであり、一時的であれ恒常的であれ**自らの身体への付属物(an appendage to their body)**として受け止められうる。その場合、必ずしも「存在すること・感じることの根本問題」の知覚の変容につながるとは限らない。

> つまり著者らは「人工呼吸は必ず自己を変容させる」とは主張していない。**変容が起こりうる**こと、その可能性が従来の枠組みで見落とされていることを問題にしている。慢性期・在宅人工呼吸のように、機械が身体の一部として統合される道筋も同時に認めている。

6. 人工呼吸を受けることと自己(Self)

呼吸不全でMVを要する状態は、エネルギー(酸素)とエネルギー産生の「廃棄物」(二酸化炭素)の代謝バランスを維持する**独立した個人的な能力**を置き換える。その置き換えは、侵襲度の広いスペクトラム(非侵襲から侵襲まで)と、患者・人工呼吸器間のインターフェースの多様性のなかで起こる。

著者らの表現はここで最も鋭くなる。

> デバイスすなわち人工呼吸器が、生の制御をその個人から奪い取り、**魂を持たない機械(a soulless machine)**へと移譲する。呼吸は機能であるだけでなく、存在の次元である。

続けて Kleinberg-Levin(2018)を引用する。呼吸は生物学的生存に不可欠であるだけでなく、**自己意識(self-awareness)の発達において特権的な機能**を帯び、真正な「個体化(individuation)」へ、終わりのない弁証法へ、覚醒へと導く、と。

この引用を踏まえて著者らが導く帰結が、本稿の中核的な主張である。

- 機械換気が自己 (Self) および対象の身体性 (Embodiment) へ及ぼす基本的な干渉を考慮すると、現象学的レベルでのその干渉は多大な影響をもつ可能性が高い
- その影響は検査値・生理学的値・古典的なアウトカム指標では記述できない
- 人工呼吸によって生じる「生きられた身体の世界への経験」の変化は、心理検査や古典的なQOL調査では十分に表現できない
- とりわけ、人工呼吸器の非同調を「呼吸するための闘い (a fight to breathe)」「機械との闘い (a fight against the machine)」として体験することは、実存的恐怖 (existential fear) に結びつきうる

△ 注意

測定できないものは無いことにされる 著者らの主張の実務的な射程はここにある。**私たちがICUで測っているもの (P/F比・ドライビングプレッシャー・鎮静深度・せん妄・退院後のQOLスコア) は、患者の存在の変容を測るようには設計されていない。**測定していないものは、カンファレンスの議題にも、QIの指標にも、研究のアウトカムにも上がらない。**非同調は「波形の異常」として扱われる限り、それが実存的恐怖でありうるという層は最後まで可視化されない。**

7. 患者自身の語りが示すもの

著者らは、呼吸困難のある患者に対する**深い語りの面接 (in-depth narrative interviews)**による質的研究 (Haugdahl HS ら、Intensive Crit Care Nurs 2017) を引き、人工呼吸中および後の呼吸という現象を照らし出す4項目を紹介する。

原語	訳	内容
existential threat	実存的脅威	生存そのものが脅かされているという感覚
tough time	つらい時間	耐え難い時間の経験
amorphous and boundless body	定形を失い際限のない身体	身体の輪郭・境界が失われる感覚
getting through	切り抜けること	何とか通り抜けようとする過程

ある患者の言葉として、次の一節が引かれる。

> 「…私はどちらかという、収納庫のなかに横たわるアメーバのようなものでした…」

この面接群から述べられたのは、**自力で呼吸できないことが、自己と他者のあいだ、その人と世界のあいだの境界を、霞んだ／不明瞭なものにする**ということであり、それは一種の「あいだの空間 (in-between space)」に在ることだとされた。

さらに著者らは、鎮痛鎮静やせん妄の影響があるにもかかわらず、患者が人工呼吸後にしばしば報告する5つの重要な主題を挙げる。

主題(原語)	訳
maintaining human dignity	人間としての尊厳を保つこと
accepting the situation	状況を受け入れること
enduring the difficulties	困難に耐えること
inadequate interaction	不十分な相互作用
a sense of unreality	非現実感

> この5主題には本文中で文献番号が付されておらず、出典は誌面から特定できない。JCで引用する際は「著者らがまとめた5主題」として扱い、原典に当たる場合は Haugdahl 2017 とは別の質的研究群を探す必要がある。

8. 臨床実践への含意 — 著者らが挙げた4つ

著者らは「呼吸困難とMVが患者の経験に与える影響は明らかに甚大であり、ケアを改善するための賢明な介入は以下を含むべきだ」として、4項目を列挙する。原文は簡潔なので、意図と実装可能性を補って表にする。

#	著者らの提案(原文の趣旨)	何を意味するか	ベッドサイドでの具体形
1	ここで論じた帰結を MVの適応判断に織り込むこと	「挿管するか否か」の判断に、生理学的利益だけでなく自己の変容という代償を計上する	挿管前カンファ／ICの際に「この人にとって人工呼吸期間は何を奪うか」を1項目として言語化する。高齢・終末期・慢性呼吸不全では特に
2	抜管後の早期の数日間 に、人・身体・場所への単純な再方向づけによって、患者が自己の感覚を取り戻すのを励ますこと	失われた「自己の輪郭」を、名前・身体・場所という最小単位から戻す	抜管後ラウンドの定型句化：氏名を呼ぶ、今日の日付と場所を告げる、手足に触れて身体の範囲を確認させる、鏡・時計・窓の外を見せる
3	家族と、可能であれば患者本人との 慎重で丁寧なコミュニケーション	相互作用の不十分さ（患者が挙げた主題の1つ）を減らす	家族面談の記録に「患者本人に伝えた内容」の欄を設ける。筆談ボード・文字盤・視線入力などの手段を挿管日に用意する
4	「 空気飢餓(air hunger) 」の賢明な問診と記録	呼吸困難を痛み・せん妄と同格のバイタルサインとして扱う	意思疎通可能な患者に1日1回「息は苦しいか」を尋ね、有無と強度をカルテの定位置に残す

著者らはこのプロセスに患者自身を含めることが、患者を「**繭のなかの冬眠者(hibernators in a cocoon)**」ではなく「**よくケアされている一人の人間**」という経験へ変えるのを助けうると述べる。

9. 著者らの留保 — 原文の慎重さのまま

本稿は主張を断定していない。留保は3か所に明示されている。

- これらの手段が「**存在論的に変容した別の人間になること**」を減じうるかどうかは、将来決定されなければならない
- 本稿の試みは**ナラティブ(narrative)**であり、**答えよりも多くの問いを残す**。なぜなら、ケアの他の副次的影響がさらに「人工呼吸を受ける経験」と絡み合いうるからである
- フッサールとメルロ＝ポンティの概念に基づき、著者らは「**存在論の扉をノックしている**」のであって、その向こうに何があるかは知らない

そして本稿は、そこに「臨床実践において患者をよりよく理解するための良い道が見つかるかもしれない」と述べ、世界内存在としての人間の役割を省察することが、「呼吸経験の生きられた身体」から切り離されることの実存的な影響をよりよく理解する助けとなり、それによって**より包括的な患者中心のケアへの扉を開く**と結ばれる。

10. 概念をベッドサイドの行為へ翻訳する

本稿の主張は抽象度が高く、そのままでは病棟で動かない。ここでは「本稿のどの主張が、当院のどの行為に対応するか」を対応表にする（右2列は本稿には無い、当院向けの翻訳）。

本稿の主張	それが起きている場面	明日から変えられる行為	記録・確認の方法
呼吸は機能でなく存在の一次元	挿管の意思決定、鎮静深度の決定	「呼吸を肩代わりする」ことの意味を家族への説明文に1行足す	ICテンプレートの改訂項目として提案
MVは人を世界の一部であることから切り離す	面会制限、個室のカーテン、窓のないベッド	窓・時計・カレンダー・家族の声を意図的に配置する。面会の柔軟化を維持する	ベッドサイド環境チェックの項目に「時計・カレンダー・窓の視野」を追加
非同調は「機械との闘い」という体験でありうる	波形ラウンド、鎮静調整	非同調を見つけたとき、設定変更の前後で患者の表情・訴えを1行記載する	呼吸ケアラウンドの記録様式に自由記載欄
身体の輪郭と境界が失われる	深鎮静、身体抑制、長期臥床	抑制の必要性を毎日問い直す。清拭・体位変換時に身体の範囲を言葉にして触れる	抑制の日次レビューは既存運用。声かけの標準文例を作る
不十分な相互作用が主要な苦痛	挿管中のコミュニケーション	筆談ボード・文字盤を挿管日に必ずベッドサイドへ。看護記録に「本人が伝えたかったこと」を残す	挿管セットの標準構成にコミュニケーション補助具を含める
空気飢餓が測られていない	日々のアセスメント	意思疎通可能な日は「息は苦しいか」を1日1回聞く	痛み・せん妄と同じ画面に記録欄を作る（電子カルテ側の改修が必要）
抜管後の再方向づけが自己を戻す	抜管当日～数日	名前・日付・場所・身体への声かけを定型化	抜管後チェックリストに1項目
体験は退室後も続く	ICU退室後訪問、ICU日記	訪問時に「人工呼吸中に何を覚えているか」を聞く枠を持つ	ICU退室後訪問 立ち上げ設計 の面談項目に反映

△ 注意

概念を運用に落とすときの落とし穴「**存在論**」という語をそのまま病棟に持ち込んでも動かない。現場で回るのは「聞く項目」「記録する場所」「声をかける文言」の3つに翻訳されたときだけである。**本稿を根拠に新しい尺度やバンドルを作るのは時期尚早**で、著者ら自身が検証されていないと明言している。まずは既存の記録様式に1～2項目を足すところから始めるのが、失敗しない導入の仕方になる。

11. 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

概念論文であるため、通常のバイアス評価(ランダム化・盲検化・追跡率)は適用できない。代わりに次の軸で吟味する。

論点	内容	JCでの問い
検証可能性	「存在論的統合性が損なわれる」という命題は、現時点で反証可能な形になっていない。何をもって「自己が変容した」とするかの操作的定義が無い	この仮説を検証する研究デザインは設計できるか。縦断的な質的研究か、既存尺度の外側を測る新規尺度の開発か
実装可能性	提案された4項目のうち、3項目(再方向づけ・コミュニケーション・空気飢餓の記録)は既存のヒューマナイゼーション施策と重なる。真に新しいのは「MVの適応判断に織り込む」点だが、具体的な判断基準は示されていない	本稿が無くても、既存のPADIS・eCASH・ABCDEFで同じ行為に到達できたのではないか。追加された価値は「理由づけ」だけか
エビデンスとの距離	参考文献は5件のみで、うち4件が哲学・人文系、臨床研究は Haugdahl 2017 の質的研究1件。系統的な文献検索は行われていない	引用の選択にバイアスは無い。反対の知見(人工呼吸を肯定的に受け止めた患者群、機械を身体の一部として統合した慢性期患者)はどれだけあるか
5主題の出典不明	人工呼吸後の5主題(尊厳・受容・忍耐・不十分な相互作用・非現実感)に文献番号が付されていない	原典に当たれない記述をJCの根拠として扱ってよい
表現の強さ	「魂を持たない機械」「繭のなかの冬眠者」は修辞として強い。人工呼吸を否定的にのみ描く枠組みは、必要な挿管をためらわせる方向に働かう	概念論文の修辞が臨床判断に与える影響をどう扱うか。著者ら自身は慢性呼吸不全患者での肯定的な受け止めに明記して均衡を取っている
一般化可能性	議論は西洋哲学(フッサール・メルロ＝ポンティ)を土台にしつつ、東洋の語彙(atman・pneuma)を並置する。日本の患者・家族の死生観にそのまま重なるかは不明	日本のICU患者の語りを、この枠組みで読んで違和感はないか
利益相反	著者2名がデバイス企業・ECMO関連団体と関係を持つ。本稿は特定製品を推奨しないため直接の影響は考えにくい、記載は確認しておく	「機械による呼吸の代替」を論じる稿として、利益相反の申告は十分か
何が変わらないか	本稿には換気設定・鎮静・離脱の管理を変える根拠は一切無い	本稿を読んで明日の指示が変わる箇所は具体的にどこか(＝ゼロでもよい。変わるのは記録と声かけ)

12. 主要な引用文献

原著の参考文献は5件のみ。哲学系4件と臨床質的研究1件で構成される。

#	内容	著者・出典・年
1	呼吸の現象学的存在論。 「呼吸経験の生きられた身体」という語の出典。学位論文	Berndtson P. Phenomenological Ontology of Breathing. JYU Dissertation 17, University of Jyväskylä, Faculty of Humanities and Social Sciences, Finland. 2018
2	「生きられた身体の世界と存在への経験的開かれ」の出典。現象学的心理学・芸術哲学の論集	Merleau-Ponty M. The primacy of perception: and other essays on phenomenological psychology, the philosophy of art, history and politics. Edie JM 編. Northwestern University Press. 1964
3	呼吸を「身体と世界の界面における空気の儚い物質化」と定義。学際的な呼吸研究	Oxley R, Russell A. Interdisciplinary perspectives on Breath, Body and World. Body Soc. 2020;26:3-29
4	呼吸が自己意識の発達と個体化に果たす特権的機能を論じる。呼吸の解釈学	Kleinberg-Levin DM. Logos and psyche—a hermeneutics of breathing. In: Škof L, Berndtson P 編. Atmospheres of breathing. State University of New York Press. 2018:124-138
5	本稿で唯一の臨床研究。人工呼吸中・後の呼吸体験を深い語りの面接で分析し4項目を抽出	Haugdahl HS, Dahlberg H, Klepstad P, Storli SL. The breath of life. Patients' experiences of breathing during and after mechanical ventilation. Intensive Crit Care Nurs. 2017;40:85-93

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 人工呼吸は肺と脳への介入であるだけでなく、「その人が世界とつながっている在り方」への介入でもある — というのが本稿の仮説である。著者らは検証されていないことを繰り返し認めており、この論文で換気設定も鎮静プロトコルも1つも変わらない。

変わるのは測っていないものを測り始めることだ。痛みとせん妄は毎日記録しているのに、患者にとって最も存在を脅かす「息が苦しい」は記録欄すら無い。まず、意思疎通できる日には1日1回「息は苦しいか」を聞いてカルテの定位置に残す — 本稿の4提案のうち当院で最も早く実装でき、最も効果が見えるのはこれである。

そして抜管後の最初の数日、名前・身体・場所を言葉にして返すこと。失われた自己の輪郭は、この最小単位から戻る。非同調を波形の異常としてだけ扱うのをやめ、「患者が機械と闘っている」と読み替えて記録に1行残すことも、今日から始められる。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。